جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : مني سيد محمد قنديل
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** الزاويه الحمراء **العنوان :** ~~
رقم البطاقة : 28601010131889 **رقم التليفون :** 01120473499 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 01-01-1986 **المهنة :** طالبة

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج الالم ومضادات القئ لمرضي الاورام المنتشر [14456] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: منى سيد محمد قنديل
National ID: 28601010131889

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Pin Medication And Anti Emetics

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية

بطاقة تحقيق الشخصية



منى

سيد محمد قنديل

١٤ ش على ابوالروس

الزاويه الحمراء - القاهره

٢٨٦٠١٠١٠١٣١٨٨٩

١٩٨٦/٠٧/٠١

JD3073339

هايل

DMS

موجة

فارلوركس

مقطعية

جوستاف روسي

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

البنك المصري من أجل صحة مصر

MDT FORM 28 / 1 / 2026 G

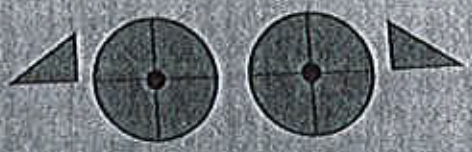
Name	[redacted]	MRN	[redacted]
		ID	[redacted]
Age	36 yrs	Phone	[redacted]
Menopausal status	perimenopausal	Marital status	
NRS SCORE		Family history	
BMI		REASON OF MDT	3rd Op c MBC
CO morbidity	Epidermolysis bullosa.		

Clinical Data

BX: IDC GII

ER:	PR:	HER 2:	KI67:
8/8	5/8	0 - ve	

R L



Sonomammography:

Mets Workup:

CT CAP → PR of HVL (1/2026) ⊕ DP of local disease

TNM

Recommendations:

1/2026 MBC to have 1st line → bony IDC GII HR+ → selected 1st line Faslodex → DP → Acx3 → very poor tolerance (due to the epidermolysis and hx) → Faslodex / Abemaciclib x3 → DP

MDT OUTCOME & PLAN PT is not fit for CR.

For 2nd line Palbociclib (low dose) / Faslodex / Ribociclib with weekly monitoring of CBC

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychia
28/1/2026					

Name: منى سيد محمد قنديل **MR. :** 5003	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient is a 40-year-old premenopausal individual with de-novo metastatic breast cancer involving the liver and bone. Initial first-line therapy consisted of Nolvadex followed by a dose-escalated protocol (DP). The patient was subsequently shifted to AC for three cycles; however, poor tolerance due to an epidermolysis condition precluded further chemotherapy. Consequently, the patient was transitioned to Zoladex plus an aromatase inhibitor for three months as a dose-escalation (DP) in preparation for a second-line trial of FASLODEX plus IBRANCE. The IBRANCE dose was reduced to 100 mg with weekly monitoring of CBC. Zoladex was administered today.

In the most recent note, the multidisciplinary team documented that on 1/2026 the patient received cycle 1 day 1 of FASLODEX and IBRANCE, along with Zoladex. The next visit is scheduled for 27/7/2026. The patient has completed one cycle of FASLODEX and IBRANCE to date.

تحريرا في ,

التاريخ :	21-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : شيماء فاروق يحيى لاشين

يعتمد ,

TAVE/
JSSY

Name : MONA SAYED MOHAMED | Date : 08-01-2026 11:49
Branch : Portable | Medical No. : GRI-286010 0 : 1889
Ref.Physician Prof : | Ins.Company :

OST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS

EVEALED: -

s compared to previous study dated 29/7/2025, the current study reveled

-Chest:

Multiple right breast and axillary tail soft tissue lesions/ nodules associated with iffuse skin thickening & multiple ipsilateral axillary level I&II pathological LNS, the largest s measuring 15mm for Sono mammography

Progressive in the size and numbers of bilateral pulmonary nodules, the largest is seen at eft upper lobe anterior segment measuring 1cm

- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2-Abdomen and pelvis:

- The liver is average in size with homogenous CT density, stationary course of hepatic focal lesions at segment VIII&VI
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and supra-renal.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

3-The scanned skeleton:

- Still seen left pubic ramus expansile mixed densities lesion
- Still seen L5 vertebra sclerotic focus
- Newly developed right iliac bone subcortical sclerotic focus
- No vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.
- Dorso-lumbar spondylosis.

OPINION:

- **Progressive course of the pulmonary metastases**
- **Stationary course of the hepatic focal lesions**
- **Newly developed right iliac bone sclerotic focus**

DR/NERMEEN RAMADAN.MD

SCAN & LABS

مركز النيل

Name : Mona Said Mohammed Qandil
Branch : Dokki
Ref.Physician Prof : Goustav Roussey Egypt

Date : 02-03-2026 08:47
Medical No. : 326003
Ins.Company : تعاقد مستشفيات

ISOTOPIC BONE SCAN REPORT

- **Indication:** 40-year-old female with history of breast carcinoma. Evaluation for possible osseous metastatic disease.
- **Radioisotope:** Tc-99m MDP
- **Imaging Protocol:** Whole-body planar images (anterior and posterior projections) acquired approximately 2–3 hours post intravenous injection.

FINDINGS:

- The scanned skeleton demonstrates no scintigraphic evidence of osseous metastatic disease.
- Age-appropriate degenerative and arthritic changes are noted involving multiple levels of the spine, the sternum, both shoulders, and the weight-bearing joints.

IMPRESSION:

- No scintigraphic evidence of osseous metastases.
- Routine clinical and scintigraphic follow-up as clinically indicated is recommended.

Best regards,
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear Medicine

ROUSSY
INTERNATIONAL

Patient Name	: الأستاذه / منى سيد محمد قنديل	Request No.	: 13006265
Patient No.	: 28601010131889	Request Date	: 04/05/2026
Path No.	: 1291/26	Verification Date	: 20/05/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 40 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Known case of breast cancer with suspicious axillary lymph node
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 04/05/2026, 12:32 pm, cold ischemia time: 20 seconds.

Gross Examination:
- One grayish white tissue core 1 cm, totally submitted.

Microscopic Examination:
- Hisotpathological examination of right axillary lymph node showed fibrotic cores infiltrated by metastatic deposits of breast origin.

Diagnosis:
Right axillary lymph node, Tru-cut biopsy:
Positive for metastatic carcinoma of mammary origin.
For further IHC (GATA-3, ER, PR and Her2).

Signature
Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim

Verified by :
Dr Maha Guimie

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name	الأستاذه / منى سيد محمد قنديل	Request No.	13006265
Patient No.	28601010131889	Request Date	04/05/2026
Path No.	1291/26	Verification Date	20/05/2026
Sex	Female	Financial Category	جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	40 Y	Department	Out Patient
Referreing Doc.		Registered by	.marwa mohamed youss

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

>1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

* Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013.IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10%of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim

Verified by :
Dr Maha Guimie

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt